Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de médecine
Cours 3eme année **Unité 1 : radiologie** **Dr ABDI.K**

Les syndromes thoraciques

I-Généralité :

a-Définition :

-Ensemble de plusieurs signes radiologiques permettant, par leur groupement, d'orienter le diagnostic.

b-Rappel anatomique :

Le thorax est composé de contenant du contenu.

Le contenant :

- Un cylindre creux formé par :12 paires de côtes,les vertèbres dorsales ,sternum.

-Muscles respiratoires : le diaphragme, les muscles intercostaux,les muscles accessoires de la respiration.

Le contenu: comprend: le médiastin, les hiles pulmonaires et le parenchyme pulmonaire.

II-Les grands syndromes thoraciques:

1-syndrome pariétal :(Fig.1)

a-Définition:

Ensemble des signes radiologiques traduisant une lésion de la paroi thoracique, c'est à dire :

-Lésions des parties molles.

-Lésions des structures osseuses.

-Une lésion des deux à la fois.

b-Sémiologie élémentaire :

Opacité localisée de tonalité hydrique, homogène dont les limites sont très variables en fonction de sa position dans le thorax.

L'identification d'une lyse osseuse est l'élément majeur dans la reconnaissance de la nature pariétale d'une opacité mais il est inconstant.

La radiographie du thorax ne permet pas un Dgc étiologique.

L'imagerie moderne scanner et IRM permet de poser le dgc de certitude.

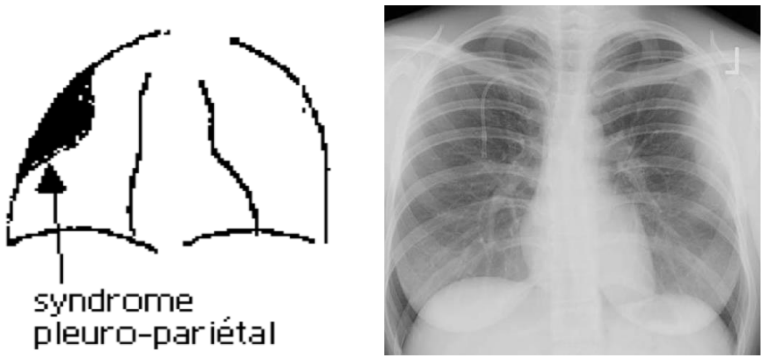


Fig.1 Syndrome pleuro-pulmonaire

2-Syndrome pleural :(Fig.2)

a-Définition:

Le syndrome pleural englobe l'ensemble des signes radiologiques traduisant la présence de liquide et/ou d'air entre les feuillets pleuraux ou de tissu anormal au niveau des feuillets pleuraux.

b-Epanchement pleural liquidien:

Épanchement liquidien libre de la grande cavité pleurale et l'accumulation du liquide dans la zone la plus déclive.

b-1-Sémiologie élémentaire:

***La radiographie du thorax :**

- **Face** : opacité hydrique homogène, limite supérieure à concavité supérieure mobile, déclive.

- **Profil** : limite supérieure également courbe, souvent floue.

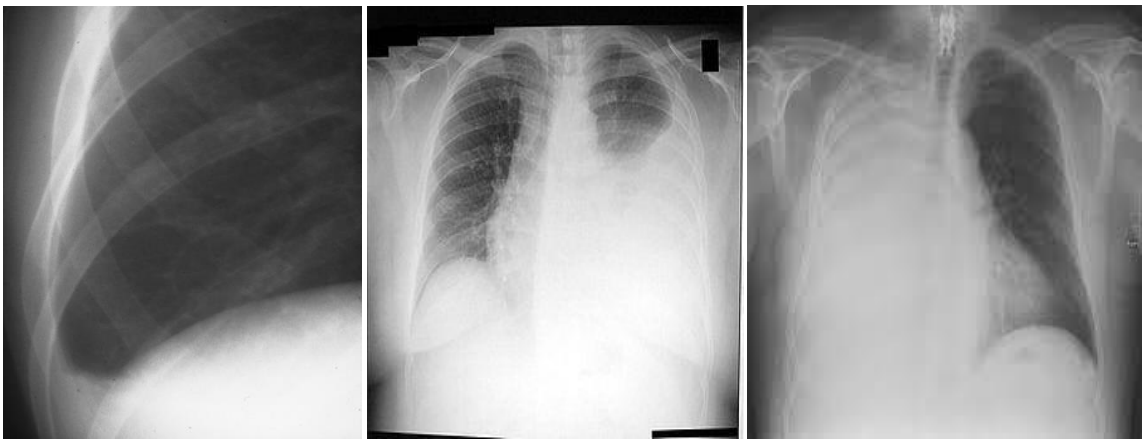

:

Fig.2 Epanchement liquidien pleural de droite à gauche : minime,de moyenne abondance et de grande abondance.

-Si épanchement très abondant : recouvre tout l'hémithorax, efface les contours du cœur et du médiastin, refoule le médiastin et la coupole diaphragmatique, élargie les espaces intercostaux.
-Si épanchement peu abondant : comblement du cul-de-sac.

***L'échographie :** permet de poser le diagnostic +: le liquide apparait anéchogene à l'échographie.
- Permet de guider les ponctions.
-Démasque les cloisonnements intra-pleuraux.

*** La TDM:**

- Etudie l'ensemble des compartiments de la cavité pleurale et mesures de densités.

c-Epanchement pleural aréique : pneumothorax (Fig.3)

C'est la a présence anormale d'air dans la cavité pleurale.

c-1 Sémiologie élémentaire :

Une hyper clarté périphérique surtout visible au sommet, ne contenant pas d'arborisation pulmonaire vasculaire (avasculaire) limitée en dedans par une ligne correspondant à la plèvre viscérale qui le sépare du poumon.

-Apicale, apico axillaire, totale

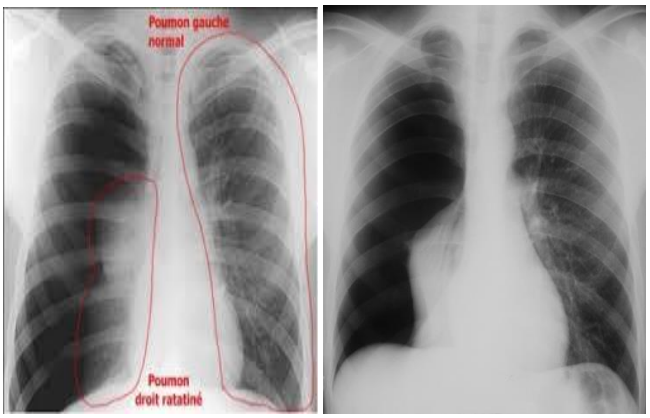


Fig.3 pneumothorax droit

-Si l'épanchement est de très faible abondance, il est plus apparent sur un cliché en expiration forcée (par augmentation de la rétraction pulmonaire).

- le pneumothorax compressif :

*Il refoule peu à peu le médiastin et le diaphragme,

*Il provoque un élargissement des espaces intercostaux,

*Il collabe finalement le poumon vers le hile,

*Il abaisse le cul de sac latéral.

d-Hydro-pneumothorax : :(Fig.4)

C'est l'association d'un épanchement liquidien et d'un épanchement gazeux. Il peut être spontané par ouverture d'une cavité pulmonaire dans la plèvre, ou secondaire après une ponction ou une plaie.

La radiographie de thorax :

Niveau hydro-aérique horizontal quelle que soit la position du patient si faisceau X horizontal.

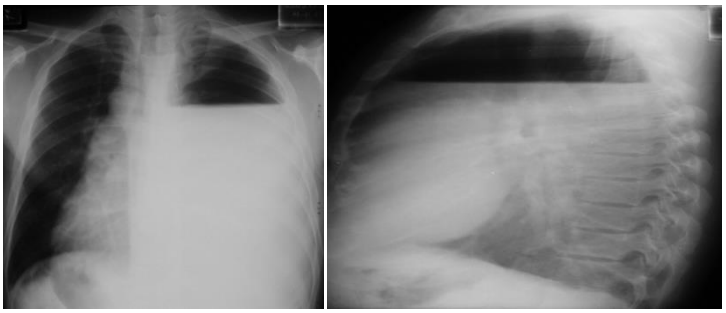


Fig.4 :Hydro-pneumothorax

e-Epaississement tissulaire:

L'épaississement peur être localisé ou diffus.

Atteinte localisée souvent bénigne : épaississement séquellaire, plaque fibro-hyaline, tumeur localisée.

Atteinte diffuse souvent maligne : tumeur diffuse, fibrothorax .

3-Syndrome alvéolaire :

a-Définition :

C'est l'ensemble des signes radiologiques traduisant le comblement des espaces alvéolaire (normalement remplie d'air) par du liquide, des cellules ou une substance amorphe.

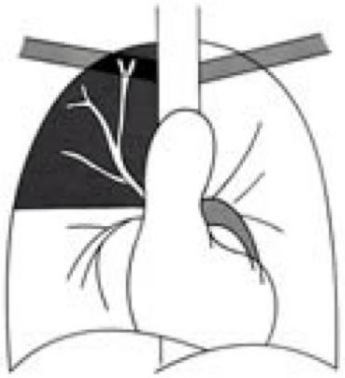


Fig.5 Syndrome alvéolaire, contenant un broncho gramme et une limite scissurale.

b-Sémiologie élémentaire :

b-1-Opacités du syndrome alvéolaire :

C'est une opacité de tonalité hydrique qui se caractérise par:

1. Limites floues (sauf si scissure)
2. Répartition systématisée (lobaire ou segmentaire)
3. Tendance à la confluence

4. Bronchogramme et/ou alvéologramme aériens
5. Répartition en ailes de papillon
6. Évolution rapide et précoce

Un ou mieux deux de ces signes suffisent à affirmer l'atteinte alvéolaire**.**

b -2 La condensation parenchymateuse: :(Fig.5,6)

Hyperdensité parenchymateuse systématisée effaçant les contours des vaisseaux pulmonaires et les parois bronchiques dessinant un bronchogramme.

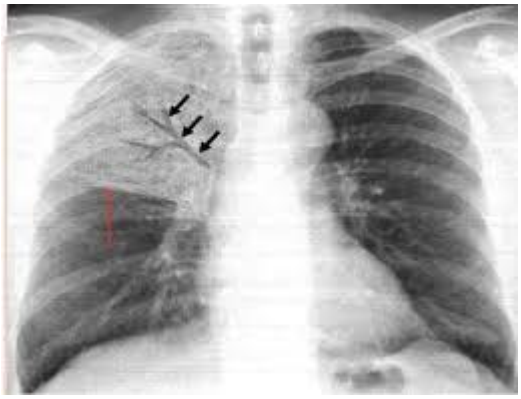


Fig.6 condensation alvéolaire

b-3 Nodule alvéolaire (Nodules acinaires ou nodules péribronchiolaires).
Opacité arrondie de 5 à 10 mm de diamètre, mal limitée, qui fusionne rapidement avec les autres nodules.

4-Syndrome interstitiel (Fig.6 et 7):

a-Définition :

Ensemble des signes radiologiques indiquant une atteinte de l'un ou de plusieurs des 3 compartiments du l'interstitium pulmonaire consécutive à :

• Une infiltration oedémateuse. (lignes de Kerley dans l'OAP.

• Une prolifération cellulaire ou de tissu anormal (granulomes, lymphangite carcinomateuse, fibrose interstitielle diffuse, …)

Ce tissu, habituellement invisible, devient radio opaque lorsqu'il s'épaissit.

b-Sémiologie :

Opacités de taille variable, nettes, non confluentes, absence de broncho gramme ou d'alvéologramme, non systématisées, elles effacent les contours péri broncho vasculaires,

de morphologie variable pouvant être réticulaires ou nodulaires ou enfin en rayon de miel dans la fibrose.

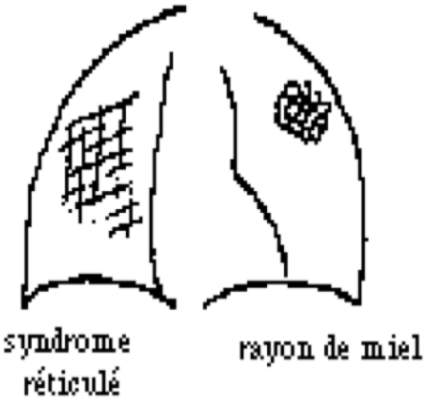


Fig.6 : syndrome interstitiel de type réticulaire droite en en rayon de miel à gauche



Fig.7: syndrome interstitiel de type micro à nodules diffus : miliaire tuberculeuse.

5-Syndrome cavitaire (Fig.8):

a-Définition :

La présence d'une ou de plusieurs cavités dans le poumon traduisent une destruction parenchymateuse ou un développement anormal des structures respiratoires.

b-Sémiologie élémentaire :

Cavité pulmonaire : est une hyperclarté parenchymateuse circonscrite, entourée d'une paroi d'épaisseur variable.

*Il faut préciser le nombre, la topographie, le caractère uni ou bilatéral et la taille ainsi que les lésions associées.

*L'analyse de l'épaisseur de la paroi et du contenu de la cavité est fondamental pour une orientation diagnostique.

La paroi: peut être

-Régulière, irrégulière ou nodulaire

-Fine ‹ 2mm ou épaisse ≥ 2mm.

Le contenu:

-Aérique pure.

-Partiellement liquidien niveau hydro-aérique.

-Partiellement solide image en grelot ou image en croissant.

C- Etiologies multiples : caverne tuberculeuse, cancer excavé, bulle emphysémateuse, abcès.

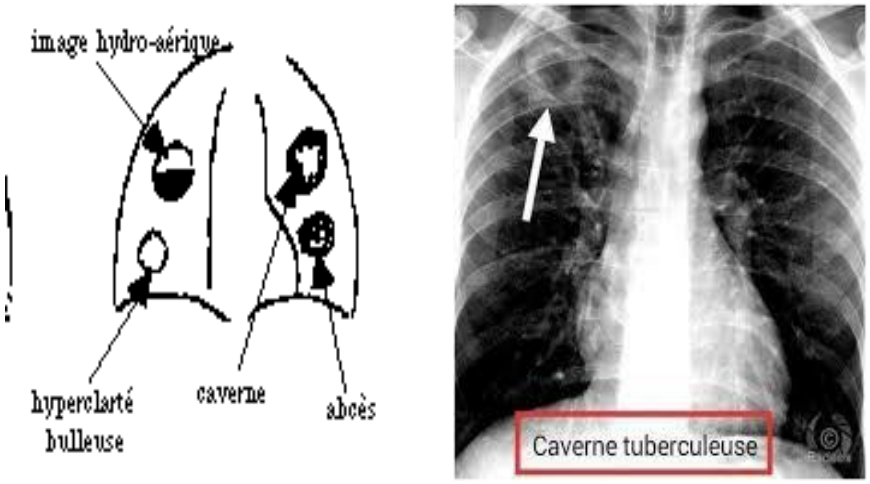


Fig.8: syndrome cavitaire : différents aspects possibles.

6-Syndrome bronchique (Fig.9) :

a-Définition:

Le syndrome bronchique se défini par l'ensemble des anomalies bronchiques pariétales et endo-luminales .ainsi que leurs conséquences en termes de troubles ventilatoires obstructifs d'aval et de perfusion du parenchyme.

Traduit soit une dilatation des bronches (DDB), soit un épaississement des parois bronchiques (bronchite chronique) ou atélectasie par obstruction bronchique de cause variable (tumeur, corps étranger, compression par une adénomégalie).

b-Sémiologie élémentaire :

La radiographie du thorax :

-Signes directs:

1-Épaississement des parois bronchiques :

Les Images en rails: Opacités linéaire parallèles dessinant des clartés tubulées.

Les images en anneau : paroi épaisse autour d'une lumière claire réalisant une image de jumelle borgne

2-Dilatation de la lumière bronchique:

Augmentation permanente du calibre bronchique par destruction irréversible de l'armature fibrocartilagineuse.

-Signes indirectes :

L'atélectasie :se présente comme une opacité systématisée segmentaire ou lobaire,rétractile à bords concaves attirant le médiastin, le diaphragme et les scissures voisines.

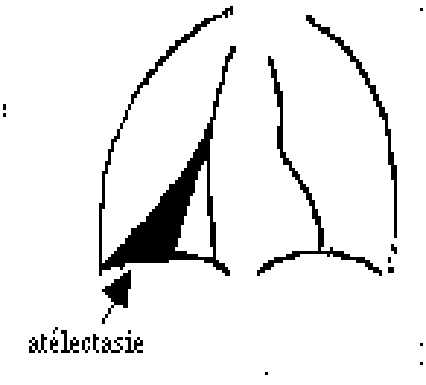


Fig.9 : syndrome bronchique de type atélectasie.

7-Syndrome médiastinal (Fig.10) :

a-Définition:

Le syndrome médiastinal regroupe l'ensemble des signes qui traduisent la présence d'air, de liquide ou de tissus anormaux à l'intérieur du médiastin.

Traduit une pathologie développée à partir du médiastin (goitre, adénomégalie, lymphome, abcès para vertébral,

méga oesophage).

b-Sémiologie élémentaire :

Opacité de tonalité hydrique, à bord externe nette continue, convexe vers le poumon se raccordant en pente douce avec les bords du médiastin,à interne noyée dans le médiastin, absence de broncho gramme.

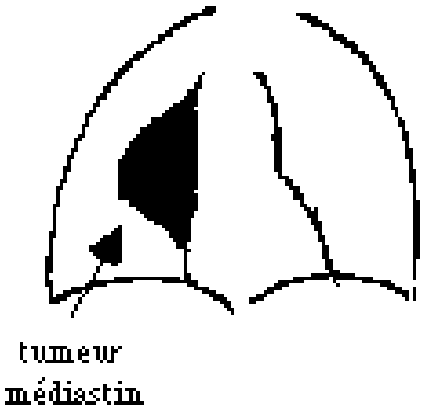


Fig.10 : Syndrome médiastinal.